

Cribado sistémico · Rodilla

PhysiQ-Assessment · fase 2. Preguntas literales de la app. Las listas de banderas rojas y amarillas de cada sistema están en la app.

URGENCIAS · TVP · ARTRITIS SÉPTICA · APARATO EXTENSOR · BURSA CON FIEBRE · NEUROVASCULAR

- TVP: no identificarla puede llevar a embolia pulmonar, que ocurre en más de un tercio de los casos. Dolor intenso e inexplicable, calambre en el hueco poplíteo, calor o hinchazón. Derivar a quien pueda excluirla.
- ARTRITIS SÉPTICA: rodilla caliente, roja y con derrame a tensión. Dolor intenso en todo el arco, incluso en recorridos mínimos. Fiebre, malestar general, incapacidad para cargar. Factores: infiltración o cirugía articular reciente, prótesis, inmunodepresión, diabetes, AR, infección cutánea, drogas parenterales. Puede coexistir con artrosis o gota y despistar. Ningún signo aislado es bastante sensible para descartarla → URGENCIA HOSPITALARIA HOY.
- ROTURA DEL APARATO EXTENSOR: la regla de Ottawa NO lo detecta. Carga excéntrica brusca sobre la rodilla flexionada o caída, con chasquido y caída inmediata. NO puede elevar la pierna extendida ni mantener la rodilla extendida contra gravedad. Escalón palpable por encima de la rótula (cuádriceps) o por debajo (rotuliano); hemartrosis; rótula alta o baja. La elevación de la pierna extendida es prueba aparte y obligatoria en toda rodilla traumática con dolor anterior. Reparación precoz (2 primeras semanas) → mejores resultados.
- Bursitis prerrotuliana séptica: la FIEBRE >37,7 °C solo se ha descrito en la séptica. Derivación el mismo día. · Compromiso neurovascular tras traumatismo: cambios de temperatura, adormecimiento, parestesias o debilidad tras fractura de meseta o luxación → pulsos distales, cribado neurológico e índice tobillo-brazo.
- REGLA DE OTTAWA, antes de explorar cualquier rodilla con traumatismo agudo → radiografía si hay ALGUNO de los cinco, por separado: ≥55 años · dolor a la palpación de la cabeza del peroné · dolor aislado a la palpación de la rótula · no flexiona hasta 90° · no carga cuatro pasos, ni justo tras la lesión ni ahora, aunque sea cojeando. S 98–100 %, E ≈50 %: sirve para descartar, no para confirmar. Excluida si la lesión tiene más de 7 días.

Vascular

1. ¿El dolor aparece tras caminar unos minutos y cede casi de inmediato al parar (claudicación)?
2. ¿Tiene la pantorrilla hinchada, caliente y más rojiza que la otra (posible TVP)? **URGENCIA · derivar hoy**
3. ¿Tiene un bulto detrás de la rodilla (quiste poplíteo) y además dolor o hinchazón en la pantorrilla? Clínicamente no se distingue de una tromboflebitis: derivar (ecografía).

Infecciosa / Inflamatoria

1. ¿Hay fiebre, enrojecimiento intenso y calor local junto con la tumefacción de la rodilla (artritis séptica)? **URGENCIA · derivar hoy**
2. ¿Ha tenido alguna infección reciente (urinaria, respiratoria, cutánea) antes de que apareciera el dolor articular?
3. ¿Tiene hinchada, caliente y roja la bolsa de delante de la rótula, y fiebre de más de 37,7 °C? **URGENCIA · derivar hoy**

Oncológico / Hematológico

1. ¿El dolor es constante, nocturno, intenso y no se alivia con ninguna posición ni reposo?
2. ¿Tiene antecedentes de cáncer o ha notado algún bulto en la zona de la rodilla o muslo?
3. ¿Ha tenido episodios de hinchazón articular después de un traumatismo menor?

Traumático / Mecánico

1. ¿Tras un golpe directo, una caída sobre la rodilla o un mal aterrizaje, se le hinchó enseguida y no puede cargar el peso sobre esa pierna? (Aplicar la regla de Ottawa en el árbol: radiografía si hay algún criterio.)
2. ¿Tras una caída o un frenazo con la rodilla doblada, notó un chasquido y ahora no puede levantar la pierna estirada ni mantener la rodilla estirada? **URGENCIA · derivar hoy**
3. ¿Fue un traumatismo de alta energía (accidente, golpe contra el salpicadero o en la parte delantera e interna de la rodilla, o la rodilla se le fue hacia atrás) con la rodilla muy hinchada de inmediato? **URGENCIA · derivar hoy**
4. ¿Desde el traumatismo nota el pie o la pierna más fríos o más calientes, dormidos, con hormigueo o con menos fuerza? **URGENCIA · derivar hoy**
5. ¿Arrastra la punta del pie o tropieza con ella, o tiene hormigueo o menos fuerza por fuera de la pierna y en el dorso del pie (nervio peroneo común)?
6. ¿La rodilla se le bloquea y no puede estirla o doblarla, con mucho dolor, derrame y pérdida de movilidad (posible fragmento osteocondral inestable → imagen y derivación)?

Niño o Adolescente

1. ¿Es un niño o adolescente con dolor de rodilla sin ningún golpe ni gesto que lo explique? (Explorar primero la cadera: epifisiólisis, Perthes.)

Endocrino / Metabólico

1. ¿Siente fatiga inusual o debilidad muscular, especialmente al subir escaleras o levantarse de una silla?
2. ¿Ha notado aumento anormal de sed, apetito o frecuencia urinaria (incluso despertándose por la noche)?
3. ¿Ha experimentado cambios recientes en su peso o tolerancia a la temperatura (mucho frío o calor cuando otros no)?
4. ¿Nota que sus heridas sanan muy lentamente o le aparecen moretones con excesiva facilidad?
5. (Si tiene diabetes) ¿Suele tener episodios de bajadas de azúcar, o siente ardor, entumecimiento o pérdida de sensibilidad en manos y pies?

Hematológico

1. ¿Sangra o se le forman moretones fácilmente después de un traumatismo menor, cirugía o procedimiento dental?
2. ¿Experimenta falta de aire, palpitaciones o dolor en el pecho con esfuerzos leves (subir escaleras) o en reposo?
3. ¿Padece infecciones recurrentes o fiebre baja frecuente (resfriados, gripe, infecciones respiratorias)?
4. ¿Ha notado heces negras/alquitranadas, sangre en orina, o ha tosido o vomitado sangre?

Un Sí aislado no implica derivación automática (salvo las preguntas de URGENCIA): evaluar en el contexto clínico completo. Generado desde los datos de la app el 6/10/2026.